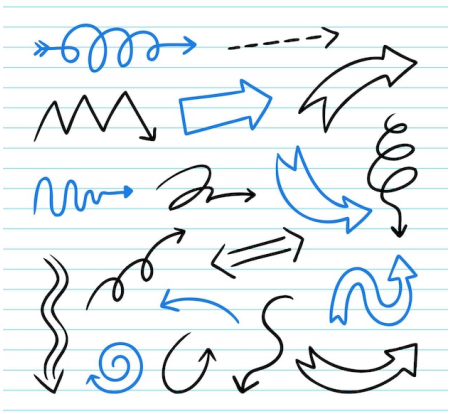


TEMA 24



ESQUEMA DEL TEMA

LEY 39/2.006, DE 14 DE NOVIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.

LEY 39/2.006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.

Exposición de Motivos.

La atención a las personas en situación de dependencia es un reto de la política social de los países desarrollados

- Asegurar los apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria.
- Alcanzar una mayor autonomía.
- Ejercer plenamente los derechos de ciudadanía.

Antecedentes de la Ley 39/2.006:

- Renovación del Pacto de Toledo (2.003) → Sistema integral de atención a la dependencia.
- Documentos de la OMS, del Consejo de Europa y de la UE → universalidad, alta calidad y sostenibilidad de las políticas de dependencia.
- Subcomisión sobre la discapacidad (2.003) → Sistema integral de atención a la dependencia.

Cambios demográficos y sociales → incremento de la población en situación de dependencia:

- Envejecimiento de la población (de más de 65 y de más de 80 años) → correlación entre edad y discapacidad.
- Dependencia por enfermedad y discapacidad.
- Dependencia por siniestralidad vial y laboral.

Necesidad de garantizar la atención a las personas dependientes:

- Hay que revisar el modelo tradicional de atención (la familia –las mujeres- como protagonista del apoyo informal).
- Superación de los límites de los arts. 49/50 de la C.E. → El desarrollo de los SS.SS. es la base del **cuarto pilar** del sistema de bienestar: la atención a la dependencia.

Objetivos de la Ley de Dependencia:

- Configurar la atención a la dependencia como una nueva modalidad de protección social, que amplía y complementa la acción del Estado y de la Seguridad Social.
- Desarrollar el sistema de Servicios Sociales complementando su acción protectora.

Título Preliminar: Disposiciones Generales.

Objeto de la Ley.

. Regular las condiciones que garanticen la igualdad en el **derecho de la ciudadanía a la autonomía personal y atención a las situaciones de dependencia**

. Mediante la **creación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAP)** con la colaboración de todas las Administraciones Públicas

. Y la garantía por la **Administración General del Estado** de un mínimo de derechos para todos los ciudadanos en el territorio español.

Acción coordinada entre la Administración del Estado y de las CC.AA.	**Participación, en su caso, de las Entidades Locales.**

Conceptos de la Ley.

Autonomía.	Capacidad de controlar, tomar decisiones personales, desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.
Dependencia.	Estado permanente de personas (edad, enfermedad, discapacidad) que por la falta o pérdida de la autonomía (física, mental, intelectual o sensorial) precisan de atención de otras personas o ayudas importantes para las actividades básicas de la vida diaria. En el caso de personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental precisan de apoyos para la autonomía personal.
Actividades básicas de la vida diaria.	Tareas elementales para desenvolverse con un mínimo de autonomía e independencia: cuidado personal, actividades domésticas básicas, movilidad, reconocimiento, orientación …
Necesidades de apoyo para la autonomía personal.	Las que requieren las personas con discapacidad intelectual/mental para un grado satisfactorio de autonomía.
Cuidados no profesionales.	Atención a personas dependientes en su domicilio por familiares o personas del entorno no vinculadas a servicios profesionalizados.
Cuidados profesionales.	Cuidados prestados por instituciones públicas o privadas o profesionales autónomos, que tienen como finalidad prestar servicios a personas dependientes en su hogar o en un centro.
Asistencia personal.	Servicios prestados por un asistente personal que colabora en las tareas de la vida cotidiana de una persona dependiente para fomentar su independencia y potenciar su autonomía personal.
Tercer Sector.	Organizaciones privadas surgidas de la iniciativa ciudadana o social, que impulsan el reconocimiento y ejercicio de los derechos sociales.

Principios de la Ley.

. Carácter público de las prestaciones. . Universalidad en el acceso. . Atención integral e integrada. . Transversalidad de las políticas de dependencia. . Valoración de las necesidades personales. . Personalización de la atención. . Medidas de prevención, rehabilitación, estímulo social y mental. . Promoción del mayor grado posible de autonomía. . Inclusión de la perspectiva de género. . Atención preferente a las personas en gran dependencia.	. Permanencia en el entorno siempre que sea posible. . Calidad, sostenibilidad y accesibilidad de los servicios. . Participación de las personas dependientes, familiares y entidades. . Colaboración de SS.SS. y sanitarios. . Participación de la iniciativa privada. . Participación del Tercer Sector. . Cooperación interadministrativa. . Integración de las prestaciones en las redes de SS.SS. de las CC.AA.

Derechos y obligaciones de las personas dependientes.

Derechos	Obligaciones
. Derechos humanos y libertades fundamentales. . Información completa y continuada. . Autorización previa en procedimientos de investigación. . Confidencialidad en la recogida y tratamiento de datos. . Participación en las políticas de bienestar, a nivel individual o como asociación. . Decisión sobre su tutela para el caso de pérdida de capacidad de autogobierno. . Libre decisión sobre ingresos residenciales. . Ejercicio de sus derechos en internamientos involuntarios. . Ejercicio de sus derechos patrimoniales. . Inicio de acciones administrativas y judiciales para la defensa de sus derechos. . Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad. . No discriminación por orientación o identidad sexual.	. Suministro de los datos requeridos por las Administraciones para la valoración de la dependencia, comunicar las ayudas que reciban y aplicar las prestaciones a la finalidad para la que se otorga.

Titulares de los derechos.

Requisitos	1.- Encontrarse en dependencia, en alguno de los grados establecidos. 2.- Para los menores de 3 años → Valoración específica (Disp. Adic. 13). 3.- Residir en territorio español, haberlo hecho **durante 5 años**, de los cuales **2** deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud (en los menores de 5 años, la residencia se exige a quienes ejercen su guarda y custodia).
Otras situaciones.	**Personas sin nacionalidad española** → L.O. 4/2.000, Tratados y Convenios. **Españoles no residentes en España** → Posibles medidas de protección. **Emigrantes españoles retornados** → Se regulará su acceso.

Título I: El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

CAPÍTULO I: CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA.

Finalidad del SAAD.	. Garantizar las condiciones básicas y contenido común de la Ley. . Ser cauce de colaboración y participación de las Administraciones. . Optimizar los recursos públicos y privados disponibles. . Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD: Instrumento de cooperación para la articulación del SAAD:

El Ministro competente en dependencia + Los Consejeros de las CC.AA. + otros representantes (con voz pero sin voto).

Funciones.	. Acordar el marco de cooperación interadministrativa. . Establecer los criterios para determinar la intensidad de los servicios. . Acordar las condiciones y cuantías de las prestaciones económicas. . Acordar los criterios de participación de los beneficiarios en el coste de los servicios. . Acordar el baremo en los procedimientos de valoración. . Acordar planes, proyectos y programas conjuntos. . Adoptar criterios comunes de actuación y evaluación del SAAD. . Facilitar documentos, datos y estadísticas comunes. . Establecer mecanismos de coordinación para personas desplazadas. . Informar la normativa estatal de desarrollo de la dependencia. . Ser cauce de cooperación, comunicación e información entre las Administraciones. . Coherencia en la aplicación y determinación de las diferentes políticas.

Papel de las diferentes Administraciones.

Estado.	. El Gobierno (oído el Consejo Territorial) determina el nivel mínimo de protección para cada beneficiario, según grado de dependencia. . Su financiación se fija en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Estado-CC.AA.	. Mediante Convenios se acuerdan las financiaciones correspondientes a cada Administración → objetivos, medios y recursos que aplica cada Administración.
CC.AA.	. Planificar, ordenar, coordinar, dirigir … los servicios de la dependencia dentro de su territorio. . Gestionar en su territorio los servicios necesarios para valorar y atender la dependencia. . Establecer procedimientos y órganos de coordinación sociosanitaria. . Crear y actualizar el Registro de Centros y Servicios facilitando su debida acreditación. . Asegurar la elaboración de los Programas Individuales de Atención (PIA). . Inspeccionar (y sancionar) los requisitos de calidad de centros y servicios. . Evaluar periódicamente el funcionamiento del Sistema en el territorio. . Aportar a la Administración Estatal la información necesaria para la financiación. ➔ Las CC.AA. pueden aportar niveles de protección adicionales a los fijados por el Estado.
Entidades Locales.	. Participar en la gestión de los Servicios de Atención a la Dependencia según la normativa y competencias vigentes.

CAPÍTULO II: PRESTACIONES Y CATÁLOGO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL SAAD.

Objetivos de las prestaciones.	. Facilitar una **existencia autónoma** en el medio habitual, todo el tiempo posible. . Proporcionar un **trato digno** en la vida personal, familiar y social, facilitando la incorporación activa en la comunidad.
Prestaciones de atención a la dependencia.	La atención a la dependencia diferencia entre **servicios** y **prestaciones económicas**. **. Los servicios son prioritarios**. Se prestan desde la red de SS.SS. de las CC.AA. mediante centros públicos o privados. . Si no se pueden prestar los servicios, se incorpora la **prestación económica vinculada al servicio.** . De forma excepcional, se puede recibir una **prestación económica para ser atendido por cuidadores no profesionales**. . Las personas dependientes pueden recibir una **prestación económica de asistencia personal.** . La prioridad en el acceso viene determinada por el grado y la capacidad económica del solicitante.

Catálogo de Servicios → Integrados en la red de SS.SS. de las CC.AA.

Servicios de prevención y promoción de la autonomía.	Prevenir la aparición o agravamiento de enfermedades o discapacidades, mediante la coordinación de SS.SS. y salud promoviendo condiciones de vida saludables y programas preventivos y de rehabilitación.
Servicio de Teleasistencia.	Tecnologías de la comunicación e información, con apoyo de medios personales, para la respuesta inmediata en situaciones de emergencia, inseguridad, soledad o aislamiento. Puede ser independiente o complementario a la Ayuda a Domicilio.
Servicio de Ayuda a Domicilio.	Actuaciones en el domicilio de las personas dependientes para atender a sus necesidades de la vida diaria, prestadas por entidades o empresas acreditadas. • Atención personal. • Atención de necesidades domésticas u hogar (se prestan si se ha concedido para ayuda personal).
Servicio de Centro de Día y de Noche.	Atención integral diurna o nocturna para mejorar/mantener el mejor nivel de autonomía y apoyar a las familias/cuidadores. • Centro de Día para mayores. • Centro de Día para menores de 65 años. • Centro de Día de atención especializada. • Centro de Noche.

Servicio de Atención Residencial.	Servicios continuados personales y sanitarios en centros residenciales habilitados al efecto. Pueden ser permanentes o temporales (descanso de cuidadores no profesionales, de convalecencia, de vacaciones …). • Residencias de mayores en situación de dependencia. • Centros de atención a personas dependientes en función del tipo de discapacidad.

Catálogo de prestaciones económicas.

Prestación económica vinculada al servicio.	. Periódica. . Solo si no es posible el acceso al servicio público de atención o cuidado. . Es personal, vinculada siempre a la adquisición del servicio. . Son supervisadas por las Administraciones.
Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.	. Excepcional, cuando el beneficiario sea atendido en el entorno familiar – siempre que se den condiciones de convivencia/habitabilidad y se establezca en el PIA-. . El cuidador debe ajustar a normas de afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social. . Se promoverá el apoyo a cuidadores no profesionales → formación, información y medidas para períodos de descanso.
Prestación económica de asistencia personal.	. Promoción de las personas en dependencia, en cualquier grado. . Contratación de asistencia personal para facilitar al beneficiario el acceso a la educación y el trabajo, así como la autonomía para las ABVD. . El Consejo Territorial establecerá las condiciones específicas en esta prestación.

Incompatibilidad entre las prestaciones.

. Las prestaciones económicas son incompatibles entre sí y con los servicios, excepto prevención y promoción y teleasistencia.

. Los servicios son incompatibles entre sí, excepto teleasistencia, que es compatible con prevención y promoción, ayuda a domicilio y centro de día / de noche.

CAPÍTULO III: LA DEPENDENCIA Y SU VALORACIÓN.

Grados de Dependencia

Grado I. Dependencia moderada.	La persona necesita ayuda para varias ABVD, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
Grado II. Dependencia severa.	La persona necesita ayuda para varias ABVD dos o tres veces al día, no requiere un apoyo permanente de cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.

Grado III. Gran dependencia.	La persona necesita ayuda para varias ABVD varias veces al día. Tienen pérdida total de autonomía, necesitan el apoyo indispensable y continuo de otra persona por necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

Valoración de la Dependencia.

Las CC.AA.	. Determinan los órganos de valoración de la situación de dependencia. . Emiten dictamen sobre el grado de la dependencia. . Especifican los cuidados requeridos.
El Consejo Territorial	. Acuerda los criterios comunes a los órganos de valoración. . Aprueba el baremo para determinar los grados de la dependencia (que lo aprueba el Gobierno mediante Real Decreto).
El baremo	. Valora la capacidad de la persona para llevar a cabo las ABVD.
La valoración tiene en cuenta	. Informes sobre la salud de la persona. . Informes sobre el entorno en que vive. . Consideración sobre ayudas técnicas, órtesis y prótesis.

CAPÍTULO IV: RECONOCIMIENTO DEL DERECHO.

. Inicio del procedimiento: A instancia de la persona afectada o quien le represente.

. Reconocimiento: Mediante resolución expedida por la Administración Autonómica correspondiente a la residencia del solicitante. Tiene validez para todo el Estado.

- Determina los servicios/prestaciones según grado y nivel de dependencia.
- Cambio de residencia → la C.A. de destino determina los servicios/prestaciones que corresponden.
- Los servicios de valoración de la dependencia, prescripción de servicios y prestaciones/gestión de prestaciones económicas se efectúan directamente por las Administraciones Públicas.

. Programa Individual de Atención:

- Lo elaboran los SS.SS. correspondientes.
- Determina las modalidades de atención con la participación previa consulta del beneficiario o familia.

Es revisado	. A instancia del interesado y sus representantes legales. . De oficio (como determine la normativa de la CC.AA.). . Por cambio de residencia a otra C.A. Las causas de la revisión son: • Mejoría/empeoramiento de la situación de dependencia. • Error de diagnóstico en la aplicación del baremo.

Las prestaciones pueden ser **modificadas / extinguidas**:

- En función de la situación personal del beneficiario.
- Cuando se produzca una variación de los requisitos.
- Por incumplimiento de las obligaciones reguladas en la Ley.

CAPÍTULO V: FINANCIACIÓN DEL SISTEMA Y APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS.

Financiación de las Administraciones.

. La financiación del Sistema se determina anualmente en los Presupuestos.

. Los Convenios Estado/CC.AA. determinan las obligaciones asumidas por cada Administración:

- Pueden ser anuales/plurianuales.
- Recogen criterios de reparto: población dependiente, dispersión geográfica …
- La aportación de la C.A. debe ser, al menos, igual que la del Estado.

Participación de los beneficiarios en el coste de las prestaciones.

. Los beneficiarios participan en la financiación según el tipo/coste del servicio y su capacidad económica personal.

Ningún ciudadano puede quedar fuera de la cobertura por no disponer de recursos económicos.

Título II: La calidad y eficacia del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

CAPÍTULO I: MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SISTEMA.

El SAAD fomentará la calidad de la atención a la dependencia	El Consejo Territorial fija los criterios de acreditación de centros y planes de calidad del SAAD: • Criterios de calidad y seguridad de centros y servicios. • Indicadores de calidad para la evaluación y mejora. • Guías de buenas prácticas. • Cartas de Servicios.

Calidad en los Servicios	Establecimiento de estándares de calidad para cada Servicio: • Los Centros Residenciales deben disponer de un reglamento de régimen interior que incluye un sistema de gestión de calidad. • Promoción de la profesionalidad y formación

CAPÍTULO II: FORMACIÓN EN MATERIA DE DEPENDENCIA.

Formación básica y permanente de profesionales y cuidadores	. Se determinarán cualifiaciones profesionales idóneas. . Se promoverán programas y acciones formativas. . Se fomentará la colaboración entre Administraciones → educación, sanidad, empleo, asuntos sociales …

CAPÍTULO III: SISTEMA DE INFORMACIÓN.

Órgano **ministerial** para garantizar la disponibilidad de la información y comunicación recíproca entre las Administraciones y la compatibilidad entre los sistemas.

CAPÍTULO IV: ACTUACIÓN CONTRA EL FRAUDE. Establecimiento de medidas de detección y persecución de los fraudes.

CAPÍTULO V: ÓRGANOS CONSULTIVOS DEL SAAD.

Órgano **ministerial** asesor en dependencia ejerciendo la participación institucional de organizaciones sindicales y empresariales:

- Informa, asesora, propone sobre el funcionamiento del SAAD.
- Composición tripartita: Administración + Empresas + Sindicatos.

Administración	**Organizaciones empresariales/sindicales**
. 6 representantes Estado. . 6 representantes CC.AA. . 6 representantes Entidades Locales.	. 9 representantes organizaciones empresariales. . 9 representantes organizaciones sindicales.
Órganos consultivos.	. Comité Consultivo del SAAD. . Consejo Estatal de Personas Mayores. . Consejo Nacional de Discapacidad. . Consejo Estatal de ONGs de Acción Social.

Título III: Infracciones y Sanciones.

Infracciones:

a.- Impedir el ejercicio de los derechos. b.- Obstruir las inspecciones. c.- Negar información / dar datos falsos. d.- Aplicar las prestaciones económicas a finalidades indebidas / recibir ayudas incompatibles con las prestaciones. e.- Incumplir las normas de autorización de apertura y funcionamiento de los centros.	f.- Tratar discriminatoriamente a las personas en dependencia. g.- Conculcar la dignidad de las personas en dependencia. h.- Generar daños o situaciones de riesgo para su integridad física / psíquica. i.- Incumplir los requerimientos de las Administraciones.

Clasificación de las infracciones:

Leves/graves /muy graves de acuerdo a:	. Riesgos para la salud. . Gravedad de la alteración social producida. . Cuantía del beneficio obtenido. . Intencionalidad. . Número de afectados. . Reincidencia.

Sanciones.

Tipos de sanciones.	**Criterios de graduación de las sanciones.**
. Pérdida de las prestaciones / subvenciones. . Multa para cuidadores no profesionales. . Multa / pérdida de subvenciones /cese temporal /cierre del establecimiento. . Reintegro de cantidades indebidamente percibidas.	. Gravedad de la infracción. . Gravedad de la alteración social. . Riesgo para la salud. . Número de afectados. . Beneficio obtenido. . Grado de intencionalidad y reiteración.

Prescripción de las infracciones.

Leves.	**Graves.**	**Muy graves.**
1 año.	3 años.	4 años.

Prescripción de las sanciones.

Leves.	**Graves.**	**Muy graves.**
1 año.	4 años.	5 años.

Competencias estatales en las infracciones.

Infracciones leves.	Al titular de la D.G. del IMSERSO.
Infracciones graves.	Al titular de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad.
Infracciones muy graves.	Al titular del Ministerio (con acuerdo previo del Consejo de Ministros en sanciones superiores a 300.000 euros o cierre de la empresa/clausura del servicio).